

Hepatitis virales: interpretación serológica y manejo

Cómo leer un perfil de hepatitis B en treinta segundos · Hepatitis aguda por VHA, VHB y VHC · Hepatitis crónicas y tamizaje antes de inmunosuprimir

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: A (interpretación de exámenes de hepatitis B), B (hepatitis aguda viral) y C (hepatitis crónicas) — Sección IV

Glosario de siglas: VHA, VHB, VHC, VHD, VHE: virus de las hepatitis A, B, C, D y E · HBsAg: antígeno de superficie del VHB · anti-HBs: anticuerpo contra el antígeno de superficie · anti-HBc: anticuerpo contra el antígeno core (IgM e IgG) · HBeAg: antígeno e · anti-HBe: anticuerpo contra el antígeno e · ADN-VHB: carga viral del VHB · ARN-VHC: carga viral del VHC · AAD: antivirales de acción directa · ALT/AST: transaminasas · RVS: respuesta viral sostenida · CHC: carcinoma hepatocelular · TAR: terapia antirretroviral · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · MINSAL: Ministerio de Salud de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en las guías AASLD y EASL de hepatitis B y C, las recomendaciones de la OMS, las guías AGA sobre profilaxis de reactivación del VHB en inmunosupresión, y la normativa chilena (GES de hepatitis crónicas y programa de inmunizaciones). **Las hepatitis virales son de notificación obligatoria en Chile y varias están cubiertas por garantías explícitas: verificar la norma y la canasta GES vigentes.**

Índice

1. Los cinco virus hepatotropos de un vistazo
2. Enfrentamiento de la hepatitis aguda
3. Hepatitis A
4. Hepatitis E
5. Hepatitis B: virología y marcadores
6. Interpretación del perfil de hepatitis B
7. Hepatitis B aguda
8. Hepatitis B crónica: fases y tratamiento
9. Reactivación del VHB: el escenario que el internista debe prevenir
10. Hepatitis D
11. Hepatitis C
12. Tamizaje y prevención
13. Hepatitis viral en el embarazo
14. Errores frecuentes
15. Perlas de alto rendimiento
16. Bibliografía esencial

1. Los cinco virus hepatotropos de un vistazo

	VHA	VHB	VHC	VHD	VHE
Genoma	ARN	ADN	ARN	ARN (defectuoso)	ARN
Transmisión	Fecal-oral	Parenteral, sexual, vertical	Parenteral (sangre)	Parenteral (requiere VHB)	Fecal-oral, zoonótica (cerdo)
Incubación	2-6 semanas	1-6 meses	2 semanas-6 meses	Variable	2-9 semanas
Cronicidad	NO	Sí (5-10 % en el adulto; > 90 % en el recién nacido)	Sí (55-85 %)	Sí (sobreinfección)	Sólo en inmunosuprimidos (genotipo 3)
Vacuna	Sí	Sí	No	Indirecta (vacuna VHB)	Disponibile sólo en algunos países

	VHA	VHB	VHC	VHD	VHE
Tratamiento	Soporte	Antivirales orales (supresión)	AAD: curación > 95 %	Interferón; bulevirtida donde exista	Soporte; ribavirina en la forma crónica

2. Enfrentamiento de la hepatitis aguda

Clínica: fase prodrómica (astenia, anorexia, náuseas, febrícula, artralgias, aversión al tabaco), seguida de fase icterica con coluria, acolia, prurito y dolor en hipocondrio derecho. Muchas infecciones son **anictericas o asintomáticas**.

Estudio inicial ante una hepatitis aguda:

Examen	Objetivo
ALT, AST, bilirrubina, fosfatasa alcalina, GGT	Patrón y magnitud del daño. En las hepatitis virales agudas, ALT > AST y ambas suelen superar 10 veces el límite normal
INR y albúmina	Función hepática: el INR prolongado es el marcador clave de gravedad
Hemograma, creatinina, glicemia	
Panel serológico viral: IgM anti-VHA, HBsAg, IgM anti-HBc, anti-VHC (con ARN-VHC si hay sospecha)	Diagnóstico etiológico. Agregar IgM anti-VHE según el contexto
Serologías adicionales según el caso	VEB, CMV, VHS (hepatitis herpética fulminante), VIH
Ecografía abdominal	Descartar obstrucción biliar, evaluar el hígado y el flujo portal
Estudio no viral	Fármacos y hierbas (la causa más frecuente de hepatitis aguda no viral), alcohol, hepatitis autoinmune (ANA, antinúcleo liso, IgG), enfermedad de Wilson en jóvenes, isquemia, Budd-Chiari

Los signos de alarma de una hepatitis aguda — indican falla hepática aguda y obligan a derivación urgente a un centro con unidad de trasplante: - **Encefalopatía hepática** de cualquier grado. - **INR $\geq 1,5$** (o prolongación progresiva). - **Bilirrubina en ascenso con transaminasas que caen** ("disociación bilirrubino-enzimática"): no es mejoría, es necrosis masiva. - Hipoglicemia, acidosis láctica, falla renal. - Reducción rápida del tamaño hepático.

3. Hepatitis A

- **Transmisión fecal-oral:** agua y alimentos contaminados, contacto persona a persona, y **transmisión sexual en HSH** (brotes documentados).
- **Nunca cronifica.** La forma **colestásica prolongada** y la **recurrente bifásica** son variantes benignas de curso largo.
- **La gravedad aumenta con la edad:** en niños suele ser asintomática; en adultos mayores de 50 años y en personas con **hepatopatía crónica** previa el riesgo de falla hepática aguda es mayor.
- **Diagnóstico:** **IgM anti-VHA** (positiva desde el inicio de los síntomas, persiste 3-6 meses). La **IgG anti-VHA** indica infección pasada o vacunación.
- **Tratamiento:** de soporte. Evitar hepatotóxicos.
- **Prevención:** **vacuna** (altamente eficaz, incorporada al programa nacional en Chile en la infancia — **verificar el calendario vigente**), higiene, agua segura, y **vacunación de grupos de riesgo:** HSH, personas con hepatopatía crónica, viajeros a zonas endémicas, personas que usan drogas, manipuladores de alimentos según normativa.
- **Profilaxis postexposición:** **vacuna** dentro de las 2 semanas del contacto (de elección en inmunocompetentes de 1 a 40 años); **inmunoglobulina** en menores de 1 año, mayores de 40, inmunosuprimidos y personas con hepatopatía crónica.
- **Notificación obligatoria** y estudio de contactos.

4. Hepatitis E

- **Genotipos 1 y 2:** transmisión fecal-oral por agua contaminada, en Asia, África y América Central. **Alta mortalidad en embarazadas (hasta 20-25 % en el tercer trimestre).**
- **Genotipos 3 y 4:** **zoonosis** por consumo de carne de cerdo o jabalí poco cocida y por productos cárnicos; distribución mundial, incluidos países desarrollados. **Puede cronificar en inmunosuprimidos** (trasplantados, VIH avanzado, quimioterapia), con progresión rápida a fibrosis.

- **Manifestaciones extrahepáticas:** síndrome de Guillain-Barré, amiotrofia neurálgica, glomerulonefritis.
- **Diagnóstico:** IgM anti-VHE y **ARN-VHE** (este último es imprescindible en el inmunosuprimido, donde la serología es poco fiable).
- **Tratamiento:** soporte en la forma aguda; en la crónica, **reducción de la inmunosupresión y ribavirina**.
- **Considerarla** en toda hepatitis aguda seronegativa, especialmente con antecedente de consumo de carne de cerdo mal cocida o de viaje.

5. Hepatitis B: virología y marcadores

- **Virus ADN** que replica a través de un intermediario de ARN mediante una transcriptasa reversa — lo que explica la actividad de los análogos de nucleósidos y nucleótidos.
- **El ADN circular covalentemente cerrado (cccDNA) persiste en el núcleo del hepatocito:** por eso el virus **no se erradica**, y por eso existe el riesgo de **reactivación** años después de una infección aparentemente resuelta.

Marcador	Qué significa
HBsAg (antígeno de superficie)	Infección activa (aguda o crónica). Su presencia por > 6 meses define la cronicidad
Anti-HBs	Inmunidad: por vacunación o por infección resuelta. Es el anticuerpo protector
Anti-HBc IgM	Infección aguda (o reactivación grave de una infección crónica)
Anti-HBc IgG (total)	Contacto previo con el virus , en cualquier momento. NO aparece con la vacunación — es el marcador que distingue infección de vacuna
HBeAg	Replicación viral activa y alta infectividad
Anti-HBe	Habitualmente indica menor replicación (pero no en el paciente con mutante precore)
ADN-VHB (carga viral)	Cuantifica la replicación: define el tratamiento y su monitorización

6. Interpretación del perfil de hepatitis B

Este es el punto de mayor rendimiento del documento y uno de los más preguntados de la infectología. La clave está en tres preguntas: ¿hay HBsAg? ¿hay anti-HBc? ¿hay anti-HBs?

HBsAg	Anti-HBc total	Anti-HBs	Interpretación
-	-	-	Susceptible: nunca infectado ni vacunado -> vacunar
-	-	+	Vacunado (inmunidad por vacuna). Anti-HBc negativo es la firma de la vacunación
-	+	+	Infección pasada resuelta , con inmunidad natural
+	+	-	Infección activa: aguda si IgM anti-HBc + ; crónica si IgM - y HBsAg > 6 meses
-	+	-	"Anti-HBc aislado" — cuatro posibilidades (ver abajo)

La regla que resuelve el 90 % de los casos - **Anti-HBs SOLO (sin anti-HBc) = VACUNADO**. - **Anti-HBs + anti-HBc = INFECCIÓN PASADA RESUELTA**. - **HBsAg presente = INFECCIÓN ACTIVA** (el IgM anti-HBc dice si es aguda o crónica).

El caso del "anti-HBc aislado" (anti-HBc positivo, HBsAg y anti-HBs negativos) tiene cuatro explicaciones posibles, y su distinción importa:

1. **Infección pasada resuelta con anti-HBs que descendió por debajo del umbral de detección** — la más frecuente.
2. **Infección oculta por VHB:** ADN-VHB detectable en suero o en hígado pese a HBsAg negativo. **Es la que confiere riesgo de reactivación bajo inmunosupresión.**
3. **Falso positivo** del anti-HBc (más probable en poblaciones de baja prevalencia).
4. **"Ventana" de la infección aguda:** entre la desaparición del HBsAg y la aparición del anti-HBs (en este caso el **IgM anti-HBc** es positivo).

Conducta ante un anti-HBc aislado: solicitar **ADN-VHB**, y si el paciente va a recibir **inmunosupresión**, tratarlo como paciente en riesgo de reactivación (sección 9).

Situaciones adicionales que conviene conocer:

- **Mutante precore / core-promotor:** paciente **HBeAg negativo y anti-HBe positivo** pero con **ADN-VHB alto y transaminasas elevadas** — es una **hepatitis crónica activa**, no una fase inactiva. **Por eso nunca se interpreta el HBeAg sin la carga viral.**
- **Mutante de escape del HBsAg:** puede dar HBsAg negativo con infección activa.

7. Hepatitis B aguda

- **Sólo el 30-50 % de los adultos presenta ictericia;** el resto cursa asintomático.
- **Riesgo de cronificación según la edad de adquisición:** **> 90 % en el recién nacido**, 25-50 % en el niño pequeño, y **sólo 5-10 % en el adulto inmunocompetente**. Esta relación inversa con la edad es un concepto central y explica por qué la vacunación universal del recién nacido es la medida más eficaz.
- **Diagnóstico:** **HBsAg positivo + IgM anti-HBc positivo.**
- **Tratamiento:** **de soporte** en la mayoría de los casos, porque la resolución espontánea es la regla en el adulto. **Se indica tratamiento antiviral (entecavir o tenofovir) en:**
 - **Hepatitis B aguda grave o fulminante** (INR $\geq$ 1,5, encefalopatía, ictericia prolongada > 4 semanas).
 - Paciente inmunosuprimido o con hepatopatía previa.
 - Coinfección con VHC o VHD.
- **Seguimiento:** HBsAg a los 6 meses para confirmar la resolución o definir cronicidad.
- **Notificación obligatoria**, estudio y vacunación de contactos y parejas.

8. Hepatitis B crónica: fases y tratamiento

Definición: HBsAg positivo por **más de 6 meses**.

Fases de la infección crónica (la nomenclatura ha sido actualizada por la EASL):

Fase	HBeAg	ADN-VHB	ALT	Denominación clásica
1. Infección crónica HBeAg positiva	+	Muy alto	Normal	"Inmunotolerante"
2. Hepatitis crónica HBeAg positiva	+	Alto	Elevada	"Inmunoactiva"
3. Infección crónica HBeAg negativa	-	Bajo (< 2.000 UI/mL)	Normal	"Portador inactivo"
4. Hepatitis crónica HBeAg negativa	-	Elevado	Elevada	Mutante precore
5. HBsAg negativo	-	Indetectable o muy bajo	Normal	Infección "oculta" / resuelta

Las fases no son secuenciales ni permanentes: un paciente puede transitar entre ellas, por lo que **el seguimiento es indefinido** aunque no se trate.

Evaluación del paciente con hepatitis B crónica:

- **HBeAg, anti-HBe, ADN-VHB, ALT seriadas.**
- **Evaluación de fibrosis:** elastografía transitoria, índices no invasivos (APRI, FIB-4), o biopsia en casos seleccionados.
- **Coinfecciones:** VHC, VHD (anti-VHD en todo HBsAg positivo) y VIH.
- **Serología de VHA** para vacunar si es susceptible.
- **Tamizaje de carcinoma hepatocelular:** **ecografía cada 6 meses** (con o sin alfafetoproteína) en **todo paciente con cirrosis**, y también en poblaciones de riesgo sin cirrosis: **antecedente familiar de CHC**, personas de origen africano o asiático a partir de cierta edad, y personas con VIH.
- **Estudio y vacunación de contactos y convivientes.**

Tratamiento — a quién:

Se trata, en general, al paciente con **hepatitis crónica activa: ADN-VHB elevado más ALT elevada o fibrosis significativa**. Además, **se trata siempre:** - **Cirrosis** (con cualquier nivel de carga viral detectable). - **Hepatitis B aguda grave.** - **Reactivación o riesgo de reactivación por inmunosupresión** (sección 9). - **Embarazo con carga viral alta**, para prevenir la transmisión vertical. - **Coinfección con VIH** (siempre, dentro de la terapia antirretroviral). - Manifestaciones extrahepáticas (poliarteritis nodosa, glomerulonefritis membranosa).

Fármacos:

Fármaco	Comentario
Tenofovir disoproxil fumarato o tenofovir alafenamida	Primera línea ; alta barrera genética a la resistencia. El alafenamida tiene mejor perfil renal y óseo
Entecavir	Primera línea ; alta barrera genética. Evitar si hubo exposición previa a lamivudina (resistencia cruzada)
Interferón pegilado	Duración finita (48 semanas) y posibilidad de pérdida del HBsAg, pero con efectos adversos importantes y contraindicado en cirrosis descompensada. Uso muy restringido
Lamivudina, adefovir, telbivudina	En desuso por baja barrera genética a la resistencia

El objetivo del tratamiento es la supresión mantenida del ADN-VHB, con normalización de ALT y, en lo posible, la pérdida del HBeAg y —el objetivo ideal, poco frecuente— la **pérdida del HBsAg** ("curación funcional"). El tratamiento es **habitualmente indefinido**.

En Chile, la hepatitis B crónica está incorporada a las garantías explícitas en salud; verificar la canasta GES vigente.

9. Reactivación del VHB: el escenario que el internista debe prevenir

Es una complicación grave, con mortalidad significativa, y enteramente prevenible.

- **Mecanismo:** la inmunosupresión permite que el cccDNA persistente reanude la replicación; al retirar la inmunosupresión, la reconstitución inmune produce una **hepatitis de rebote**, que puede ser fulminante.
- **A quién tamizar:** a **TODO** paciente que vaya a recibir inmunosupresión o quimioterapia, con HBsAg, anti-HBc total y anti-HBs.

Estratificación del riesgo:

Riesgo	Situación	Conducta
Alto (> 10 %)	HBsAg positivo con rituximab u otro anti-CD20; trasplante de precursores hematopoyéticos; anti-HBc positivo con anti-CD20	Profilaxis antiviral (entecavir o tenofovir), iniciada antes de la inmunosupresión y mantenida al menos 6-12 meses después de terminarla (12-18 meses tras anti-CD20)
Moderado (1-10 %)	HBsAg positivo con corticoides en dosis moderadas o altas >= 4 semanas , anti-TNF, inhibidores de citoquinas, antraciclinas; anti-HBc positivo con corticoides prolongados o anti-TNF	Profilaxis antiviral en la mayoría de los casos
Bajo (< 1 %)	Anti-HBc positivo con inmunosupresión leve; corticoides en dosis bajas o cursos breves; metotrexato o azatioprina en monoterapia	Monitorización con ALT y ADN-VHB, con tratamiento anticipado si hay reactivación

Puntos operativos:

- La profilaxis es con **entecavir o tenofovir**, no con lamivudina.
- El **anti-HBc positivo aislado también confiere riesgo**, especialmente con anti-CD20: no basta con mirar el HBsAg.
- La **vacunación no reemplaza la profilaxis** en el paciente ya infectado.
- **Verificar siempre el estado de VHB antes de indicar rituximab:** es la asociación de mayor riesgo y la que con más frecuencia se pasa por alto.

10. Hepatitis D

- **Virus ARN defectuoso** que **requiere el HBsAg del VHB** para ensamblarse: **sólo infecta a personas con hepatitis B**.
- **Dos escenarios:**
 - **Coinfección** (VHB y VHD simultáneos): hepatitis aguda con frecuencia bifásica; **la cronificación es poco frecuente** porque depende de que el VHB cronifique.
 - **Sobreinfección** (VHD sobre una hepatitis B crónica): **cuadro grave, con alta tasa de cronificación y progresión acelerada a cirrosis y carcinoma hepatocelular**. Es la forma más temida.
- Es la **hepatitis viral crónica de peor pronóstico**.

- **Tamizaje: anti-VHD en TODO paciente HBsAg positivo** — es una recomendación frecuentemente omitida. Confirmar con ARN-VHD.
- **Tratamiento:** interferón pegilado (eficacia limitada); **bulevirtida**, un inhibidor de entrada, ha sido aprobado en algunas regiones con resultados prometedores. **Verificar disponibilidad local.**
- **La prevención es la vacunación contra el VHB.**

11. Hepatitis C

- **Transmisión parenteral:** personas que usan drogas inyectables (la principal vía actual), transfusiones anteriores al tamizaje universal, procedimientos con material no estéril, tatuajes y perforaciones en condiciones inseguras, exposición ocupacional. **La transmisión sexual es ineficiente** salvo en **HSH con VIH** o prácticas de riesgo, donde se han descrito brotes. La **transmisión vertical** ocurre en aproximadamente el 5 % (mayor con coinfección por VIH).
- **La infección aguda es asintomática en el 70-80 %**, lo que explica el diagnóstico tardío.
- **Cronifica en el 55-85 %** de los casos.
- **Progresión:** cirrosis en el 15-30 % a 20 años, con riesgo posterior de descompensación y de **carcinoma hepatocelular** (que puede aparecer incluso tras la curación virológica, en pacientes con cirrosis establecida).
- **Manifestaciones extrahepáticas:** **crioglobulinemia mixta** (vasculitis, púrpura, neuropatía, glomerulonefritis membranoproliferativa), linfoma no Hodgkin de células B, porfiria cutánea tarda, liquen plano, resistencia a la insulina, tiroiditis.

Diagnóstico:

```

ANTI-VHC (tamizaje)
  |
+---+-----+
NEGATIVO  POSITIVO
  |        |
Sin infección | ARN-VHC (carga viral) – SIEMPRE se requiere para confirmar
(salvo ventana |
o inmuno-      +---+-----+
supresión) DETECTABLE  NO DETECTABLE
              |          |
            INFECCIÓN ACTIVA  Infección PASADA resuelta
            -> TRATAR          (espontáneamente o tratada)
                               o falso positivo del anti-VHC

```

El anti-VHC permanece positivo de por vida tras la curación: por eso **el seguimiento post tratamiento se hace con ARN-VHC, nunca con el anticuerpo.**

Tratamiento — la revolución de los antivirales de acción directa:

- **Los AAD curan a más del 95 % de los pacientes**, con esquemas **orales de 8-12 semanas**, muy bien tolerados y sin interferón ni ribavirina en la mayoría de los casos.
- **Esquemas pangenotípicos** (activos frente a todos los genotipos): **sofosbuvir-velpatasvir** y **glecaprevir-pibrentasvir**. Su disponibilidad ha simplificado enormemente el tratamiento, hasta el punto de que **la genotipificación ya no es imprescindible** en la mayoría de los escenarios.
- **Se debe tratar a toda persona con infección crónica**, con muy pocas excepciones (expectativa de vida muy limitada por otra causa).
- **Antes de tratar:** evaluar **fibrosis** (elastografía, FIB-4), **descartar coinfección por VHB** (por el riesgo de reactivación durante el tratamiento con AAD), **revisar interacciones farmacológicas** (que son numerosas: amiodarona con sofosbuvir está contraindicada; estatinas, anticonvulsivantes, inhibidores de bomba de protones, antirretrovirales requieren ajuste), y evaluar la función renal y hepática.
- **Respuesta viral sostenida (RVS):** ARN-VHC indetectable **12 semanas después de terminar el tratamiento. Equivale a la curación.**
- **Después de la curación:** el paciente **con cirrosis mantiene el tamizaje de carcinoma hepatocelular con ecografía cada 6 meses, de por vida**. El paciente sin fibrosis avanzada no requiere seguimiento hepático específico, pero sí educación para evitar la reinfección.
- **No existe inmunidad protectora: la reinfección es posible**, lo que exige medidas de reducción de daño en poblaciones de riesgo.

- En Chile, la hepatitis C crónica está incorporada a las garantías explícitas en salud: verificar la canasta GES vigente.

12. Tamizaje y prevención

Virus	Tamizaje	Prevención
VHA	No de rutina	Vacuna (2 dosis); higiene y agua segura. Vacunar a hepatópatas crónicos, HSH, viajeros, personas que usan drogas
VHB	Embarazadas, personas con VIH, contactos de casos, personas que usan drogas, HSH, personas en diálisis, personal de salud, migrantes de zonas de alta prevalencia, y TODO paciente antes de inmunosupresión	Vacuna (esquema de 3 dosis; existen esquemas acelerados y de 2 dosis con adyuvante). Verificación de anti-HBs post-vacunación en personal de salud, dializados e inmunosuprimidos (objetivo ≥ 10 mUI/mL). Vacunación universal del recién nacido , más inmunoglobulina si la madre es HBsAg positiva
VHC	Tamizaje universal al menos una vez en la vida adulta (recomendación de la OMS y de los CDC), y periódico en poblaciones de riesgo	No hay vacuna. Reducción de daño, material estéril, tamizaje de donantes
VHD	Anti-VHD en todo HBsAg positivo	Vacuna contra el VHB
VHE	Según contexto	Higiene, agua segura, cocción adecuada de la carne de cerdo

Profilaxis postexposición del VHB (pinchazo, exposición sexual): depende del **estado vacunal y de la respuesta de anticuerpos del expuesto** y del **estado del caso fuente**. Combina **vacuna** y, en las situaciones de mayor riesgo, **inmunoglobulina específica anti-HB**, administrada lo antes posible (idealmente dentro de las 24 horas y hasta 7 días). **Verificar el protocolo institucional de exposición laboral.**

Todas las hepatitis virales son de notificación obligatoria en Chile: verificar el decreto vigente.

13. Hepatitis viral en el embarazo

Virus	Consideraciones
VHB	Tamizaje universal con HBsAg en el embarazo. Todo recién nacido de madre HBsAg positiva debe recibir vacuna e inmunoglobulina específica dentro de las primeras 12 horas de vida. Si la carga viral materna es alta (habitualmente > 200.000 UI/mL), se indica tenofovir en el tercer trimestre para reducir la transmisión vertical. La lactancia no está contraindicada si el recién nacido recibió la inmunoprofilaxis
VHC	Tamizaje en el embarazo según recomendación vigente. Los AAD no se usan durante el embarazo (datos insuficientes): se trata después del parto. La lactancia no está contraindicada, salvo grietas sangrantes
VHA	Vacuna segura en el embarazo si hay indicación
VHE	Alta mortalidad materna con genotipos 1 y 2 en el tercer trimestre; evitar exposición en zonas endémicas
VHS	La hepatitis herpética es rara pero fulminante en el embarazo: transaminasas extremadamente elevadas con bilirrubina relativamente baja. Requiere aciclovir endovenoso precoz

Diferencial obligado en el embarazo: hígado graso agudo del embarazo, síndrome HELLP, colestasis intrahepática del embarazo, preeclampsia con compromiso hepático.

14. Errores frecuentes

- **Confundir vacunación con infección pasada:** el anti-HBc es el marcador que las distingue.
- **Interpretar el HBeAg sin la carga viral** y pasar por alto una **mutante precore** (HBeAg negativo con ADN alto y ALT elevada = hepatitis activa).
- **No solicitar ADN-VHB ante un anti-HBc aislado**, sobre todo antes de inmunosuprimir.
- **No tamizar VHB antes de indicar rituximab, corticoides prolongados o anti-TNF.**
- **Usar lamivudina** para la profilaxis de reactivación.
- **Interpretar un anti-VHC positivo como infección activa** sin solicitar ARN-VHC.
- **Hacer seguimiento post tratamiento de VHC con anti-VHC**, que queda positivo de por vida.
- **No descartar coinfección por VHB antes de iniciar antivirales de acción directa** contra el VHC.
- **No revisar las interacciones de los AAD** (amiodarona, estatinas, anticonvulsivantes, antirretrovirales).
- **No tamizar VHD** en un paciente HBsAg positivo.
- **Suspender el tamizaje de carcinoma hepatocelular** tras la curación del VHC en un paciente con cirrosis.
- **No pensar en hepatitis E** ante una hepatitis aguda seronegativa.
- **No reconocer la disociación bilirrubino-enzimática** como signo de falla hepática, y no derivar.

15. Perlas de alto rendimiento

- **Anti-HBs solo = vacunado. Anti-HBs + anti-HBc = infección pasada. HBsAg presente = infección activa.**
- **El anti-HBc no aparece con la vacuna:** es el marcador que separa vacunación de infección.
- **HBsAg > 6 meses define cronicidad. IgM anti-HBc marca la infección aguda.**
- **HBeAg negativo con ADN alto y ALT elevada = mutante precore = hepatitis crónica activa.**
- **Anti-HBc aislado: pedir ADN-VHB,** y considerar riesgo de reactivación si se va a inmunosuprimir.
- **Tamizar VHB (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs) a TODO paciente antes de inmunosupresión,** especialmente antes de rituximab.
- **La profilaxis de reactivación es con entecavir o tenofovir,** no lamivudina, y se mantiene 6-12 meses tras terminar la inmunosupresión (12-18 tras anti-CD20).
- **El riesgo de cronificación del VHB es inversamente proporcional a la edad de adquisición:** > 90 % en el recién nacido, 5-10 % en el adulto.
- **Anti-VHD en todo HBsAg positivo:** la sobreinfección por VHD es la hepatitis crónica de peor pronóstico.
- **Anti-VHC positivo requiere ARN-VHC** para confirmar infección activa; el anticuerpo persiste tras la curación.
- **Los AAD curan más del 95 % del VHC en 8-12 semanas,** con esquemas pangenotípicos.
- **La RVS a las 12 semanas equivale a curación,** pero el paciente **con cirrosis mantiene el tamizaje de hepatocarcinoma de por vida.**
- **No hay inmunidad protectora frente al VHC: la reinfección es posible.**
- **El VHE genotipo 3 se adquiere por carne de cerdo mal cocida y puede cronificar en inmunosuprimidos;** los genotipos 1 y 2 son graves en la embarazada.
- **INR >= 1,5 o encefalopatía en una hepatitis aguda = falla hepática aguda = derivación urgente.**

16. Bibliografía esencial

- Terrault NA, Lok ASF, McMahon BJ, et al. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. *Hepatology*. 2018;67:1560-99.
- European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. *J Hepatol*. 2017;67:370-98.
- Ghany MG, Morgan TR; AASLD-IDSA Hepatitis C Guidance Panel. Hepatitis C guidance 2019 update: AASLD-IDSA recommendations for testing, managing, and treating hepatitis C virus infection. *Hepatology*. 2020;71:686-721.
- European Association for the Study of the Liver. EASL recommendations on treatment of hepatitis C. Edición vigente.
- Reddy KR, Beavers KL, Hammond SP, et al. American Gastroenterological Association Institute guideline on the prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy. *Gastroenterology*. 2015;148:215-9.
- World Health Organization. *Guidelines for the care and treatment of persons diagnosed with chronic hepatitis C virus infection*. Edición vigente.
- Kamar N, Izopet J, Pavio N, et al. Hepatitis E virus infection. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17086.
- Ministerio de Salud de Chile. Guías clínicas GES de hepatitis B y C crónicas; Programa Nacional de Inmunizaciones. Verificar las versiones vigentes en www.minsal.cl.